高性价比养生调理指南

没时间啃完养生理论，

用一本书的硬数据，分清哪些调理真能改善状态

养生的底层逻辑，先排除"累"的病根 • 疲劳自查，六类常见"累"法与对号入座 • 中医体…

144 条建议 | A 级证据 60 条 | 3 条原始文献链接 | 可按性价比筛选

讲亚健康和疲劳的底层逻辑——先排除「累」的病根，再谈调理，讲九种体质的国标自评、亚健康八型辨证的边界，讲八段锦太极拳、呼吸与正念这些零成本工具的真实证据，讲穴位推拿、艾灸拔罐刮痧足浴各自能做什么不能做什么，讲食疗药膳和抗疲劳补剂的证据分级，也讲养生智商税大全。144 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引《亚健康中医临床指南》、GB/T 46939—2025 体质国标、NICE/CDC 指南与公开研究。不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数。

生成于 2026-10-27 10:02（北京时间）

正文以在线版为准：https://kexin1409.github.io/how-to-nourish-better/

在线检索与本 PDF 的最新版都在 https://github.com/kexin1409/how-to-nourish-better

目录

前言 1

各节简介 4

1. 养生的底层逻辑，先排除"累"的病根 5

2. 疲劳自查，六类常见"累"法与对号入座 9

3. 中医体质，九种体质与国标自评 13

4. 亚健康八型辨证，指南怎么说 17

5. 传统功法，证据相对最好的一类 21

6. 呼吸与放松，最便宜的状态工具 25

7. 穴位按摩与推拿，有证据的与没有的 29

8. 外治法，艾灸拔罐刮痧与足浴 33

9. 食疗与药膳，怎么吃真能改善状态 37

10. 保健品与补剂，抗疲劳证据分级表 41

11. 起居作息与环境，状态管理的日常基建 45

12. 避坑清单，养生智商税大全 49

前言

讲亚健康和疲劳的底层逻辑——先排除「累」的病根，再谈调理，讲九种体质的国标自评、亚健康八型辨证的边界，讲八段锦太极拳、呼吸与正念这些零成本工具的真实证据，讲穴位推拿、艾灸拔罐刮痧足浴各自能做什么不能做什么，讲食疗药膳和抗疲劳补剂的证据分级，也讲养生智商税大全。144 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引《亚健康中医临床指南》、GB/T 46939—2025 体质国标、NICE/CDC 指南与公开研究。不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数。

这本书想回答的问题

问题	去哪看
养生的底层逻辑：为什么先排除「累」的病根？	1. 养生的底层逻辑，先排除"累"的病根
疲劳自查：六类常见「累」法怎么对号入座？	2. 疲劳自查，六类常见"累"法与对号入座
中医体质：九种体质与国标自评怎么看？	3. 中医体质，九种体质与国标自评
亚健康八型辨证：指南怎么说、边界在哪？	4. 亚健康八型辨证，指南怎么说
传统功法：八段锦太极拳有多少证据？	5. 传统功法，证据相对最好的一类
呼吸与放松：最便宜的状态工具怎么用？	6. 呼吸与放松，最便宜的状态工具
穴位按摩与推拿：哪些有证据哪些没有？	7. 穴位按摩与推拿，有证据的与没有的
外治法：艾灸拔罐刮痧足浴的边界在哪？	8. 外治法，艾灸拔罐刮痧与足浴
食疗与药膳：怎么吃真能改善状态？	9. 食疗与药膳，怎么吃真能改善状态
保健品与补剂：抗疲劳证据怎么分级？	10. 保健品与补剂，抗疲劳证据分级表
起居作息与环境：状态管理的基建做什么？	11. 起居作息与环境，状态管理的日常基建
避坑清单：养生智商税都有哪些套路？	12. 避坑清单，养生智商税大全

怎么读

- 不用全做：这是一份按性价比排好的备选单，不是任务清单。挑走一两条就算数，剩下的放着，需要时再回来查。
- 想按条件挑：打开在线检索页（https://kexin1409.github.io/how-to-nourish-better/），可以按关键词、章节、证据等级来筛，也可以按「花不花钱、花多少时间、要不要毅力」这三样筛，几个条件能叠着用。页面上的内容直接取自 book/ 目录里的正文，正文一改，页面跟着改。
- 条目之间会互相指路（「见第 4 节第 7 条」这种）：在线检索页里点一下就能跳过去。在这份 PDF 里点不动，但每处指路都写明了指向哪一条，不翻过去也知道说的是什么。
- 想按顺序读：每节内的条目按性价比从高到低排列，从每节前几条开始看就行。
- 只想看结论最硬的：在在线检索页里勾选证据等级 A，只留下书中有具体数字、回测或统计规律支撑的 60 条。
- 只想看最值得做的：勾选性价比「极高」，得到 39 条几乎不花钱、不花时间、不太需要毅力，收益又落在最大一档的条目。
- 想让 AI 帮你查：仓库里带了正文，把问题原样丢给能读文件的 AI 助手，让它先查相关条目、再按书里的口径回答，并注明出自第几节第几条。查不到就说查不到，不自己编数字。

证据分级

等级	含义
A	书中有具体数字、可复现的实验或大规模账户数据支撑（如巴伯与奥丁 78000 户的周转率—收益回测、卡尼曼与特韦尔斯基的前景理论实验、席勒 36 国 5 年涨跌反转统计）
B	有单一研究或较实在的论据支撑，但样本较小或偏定性；或由机制逻辑推导、有多个案例侧面印证
C	芒格式的经验观察、作者观点或业界共识，没有直接的研究文献

全书 144 条中 A 级 60 条、B 级 54 条、C 级 30 条，另有 0 条标注了争议、0 条含待核实内容。有争议的条目会在备注里列出反方证据。所有来源只引原始文献（期刊论文附 DOI 或 PubMed 链接，或 WHO/CDC/国家卫健委等官方机构报告），不引二手转述。

性价比档

证据等级只回答「这个数字可不可信」，不回答「这件事值不值得做」。所以每条还另外标了两样：收益量级（好处有多大：大/中/小）和口径（换回的是哪一类东西：慢病/死亡率/时间等）。拿收益量级加上三项成本（钱、时间、毅力），合出一个性价比档：几乎不花什么成本、换回的好处又大的，是「极高」；其次「高」，再次「一般」。不同口径之间不做比较——「死亡率低 12%」和「每天省 10 分钟」不在一把尺子上。全书 144 条中性价比极高 39 条、高 80 条、一般 25 条。

每条建议长这样

```
### 2. 肝气郁结型：胸胁满闷，情绪低落
<!-- 成本标签：钱=0 时间=少 毅力=否 收益=中 -->
- 成本：零（识别）
- 说人话：表现是胸胁满闷、喜太息、周身窜痛、时发时止、情绪低落或急躁易怒、咽喉异物感（梅核气）、月经不调，脉弦。指南用柴胡疏肝散加减
- 收益：认清"气出来的病"长什么样
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：《亚健康中医临床指南》（2020）
- 备注：和焦虑抑郁的躯体化高度重叠，持续情绪低落请先按第 1 节就医
```

「说人话」把「收益」栏里研究里的写法，翻成「看清大势、别在萧条期all in」这样的日常说法。它只用「收益」栏已经写到的内容，不添新数字，只看这一行就够拿主意。「收益」栏里原样留着全部数字，想自己核对就看那一栏。

各节简介

1. 养生的底层逻辑，先排除"累"的病根：养生内容最大的坑，是把所有不舒服都当成"虚"，然后卖你一套调理方案。

2. 疲劳自查，六类常见"累"法与对号入座：同样一句"累"，背后的机制完全不同，对策也完全不同。

3. 中医体质，九种体质与国标自评：中医调理的入口是"辨体"——先弄清自己是什么体质，再谈怎么调。

4. 亚健康八型辨证，指南怎么说：中华中医药学会《亚健康中医临床指南》（2020）把亚健康分为八个证型，每个证型有对应的经典方剂。

5. 传统功法，证据相对最好的一类：八段锦、太极拳、五禽戏这类传统功法，是中医体系里少有的被大量随机对照试验反复验证的干预。

6. 呼吸与放松，最便宜的状态工具：深呼吸、正念、肌肉放松——这些零成本、随时可做的小工具，是压力型疲劳的对症解。

7. 穴位按摩与推拿，有证据的与没有的：按摩和穴位是养生消费的大头，也是话术最密集的地带。

8. 外治法，艾灸拔罐刮痧与足浴：艾灸、拔罐、刮痧、足浴是"养生馆四大件"。

9. 食疗与药膳，怎么吃真能改善状态："吃"是养生里水最深的一章：一边是《中国居民膳食指南》的硬证据，一边是阿胶燕窝人参的软营销。

10. 保健品与补剂，抗疲劳证据分级表：保健品是养生消费的最大单类。

11. 起居作息与环境，状态管理的日常基建：调理养生到最后，落点都是日常：几点睡、几点见光、坐多久、喝不喝酒。

12. 避坑清单，养生智商税大全：这一节是全书的反面清单：把养生行业最常用的套路逐个拆掉。

1. 养生的底层逻辑，先排除"累"的病根

养生内容最大的坑，是把所有不舒服都当成"虚"，然后卖你一套调理方案。这一节先把尺子立稳：持续疲劳是一种症状，不是一种体质；先排除能治的病，再谈调理。

1. 亚健康的官方定义：有症状、没器质性病变

- 成本：零
- 说人话：中华中医药学会《亚健康中医临床指南》（2020）的定义是：人体处于健康和疾病之间的一种状态，表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退——但去医院检查，查不出明确的器质性病变
- 收益：给"浑身不得劲又查不出病"一个正式名分，也知道它的边界
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中华中医药学会《亚健康中医临床指南》（2020）
- 备注：亚健康是"功能性"描述，不等于没事，也不等于有病

2. "累"是症状，不是诊断：先抽血排查六类病因

- 成本：一次基础体检抽血，几百元
- 说人话：持续疲劳背后最常见的是六类可治疗问题：贫血、甲状腺功能减退、睡眠呼吸暂停、糖尿病、抑郁、药物副作用。不先排查就直接吃补品，可能耽误真正的病因
- 收益：把"补"的钱花在刀刃上，先确诊再调理
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：慢性疲劳诊疗的通用路径，见 NICE 与 CDC 相关指南及《中国甲状腺功能减退症诊治指南》（2017）
- 备注：基础检查清单：血常规、甲功（TSH）、血糖、维生素 B12、铁蛋白、维生素 D

3. 贫血：最常见、最便宜、最好治的一个

- 成本：一次血常规加铁蛋白
- 说人话：中国 18 岁及以上居民贫血率约 8.7%，以缺铁性贫血为主。面色差、乏力、头晕、爬楼喘，都可能只是缺铁。补铁之前先查铁蛋白，别自己乱补——过量补铁伤肝
- 收益：确诊后几十元的铁剂就能明显改善
- 证据等级：A
- 风险：中（未经诊断补铁有过量风险）
- 来源：《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》；铁剂改善疲劳的 RCT 见 BMJ 相关试验
- 备注：女性、素食者、消化道出血史、经量大的尤其要查

4. 甲状腺功能减退：乏力、嗜睡、体重增加的组合

- 成本：一次甲功（TSH）
- 说人话：如果"累"伴随着怕冷、嗜睡、体重增加、皮肤干燥、便秘，查一个 TSH。甲减的诊断和治疗都很成熟，但它伪装成的正是"气虚体质"，容易被养生话术接走
- 收益：一个指标把"调理"升级为"治疗"
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：《中国甲状腺功能减退症诊治指南》（2017）
- 备注：女性发病率显著高于男性

5. 睡眠呼吸暂停：打鼾加白天嗜睡，别当"睡得香"

- 成本：一次睡眠监测（多导睡眠图）
- 说人话：鼾声大、夜里憋气、白天秒睡、晨起口干头痛，可能是睡眠呼吸暂停。缺氧直接制造疲劳，吃任何补品都盖不住。减肥、侧卧、呼吸机都是成熟方案
- 收益：把一个被误当"体虚"多年的病真正解决
- 证据等级：A
- 风险：低（不治疗的风险反而高：高血压、心梗风险升）
- 来源：睡眠呼吸暂停诊疗指南（中华医学会）
- 备注：肥胖、颈粗、下颌后缩是高危因素

6. 抑郁和焦虑：疲劳是核心症状之一

- 成本：一次精神科或心理科门诊
- 说人话：持续疲劳加兴趣下降、早醒、注意力差、情绪低，要想到抑郁焦虑。约 40%–70% 的慢性疲劳患者伴抑郁症状。这是病，有成熟治疗，不是"想开点"或"补气血"能解决的
- 收益：把最耽误不起的病因先筛出来
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：慢性疲劳与情绪障碍共病的流行病学数据，见 MSD 诊疗手册及相关综述
- 备注：疲劳可以是抑郁的首发和唯一躯体主诉

7. 药物性疲劳：换个服药时间可能就好了

- 成本：零
- 说人话：他汀类、β 受体阻滞剂、部分抗组胺药、含镇静成分的复方感冒药，都可能引起疲劳。如果疲劳和用药时间对得上，和开药医生聊一句，也许调方案就能解决
- 收益：零成本的排查
- 证据等级：A
- 风险：低（自行停药有风险，必须经医生）
- 来源：药物不良反应的常规认知，见药品说明书与 MSD 诊疗手册
- 备注：永远不要因为"累"自己停药

8. 红旗信号：出现这些，别调理，直接就医

- 成本：零
- 说人话：疲劳超过 6 个月且进行性加重、不明原因体重下降、持续发热、夜间盗汗、淋巴结肿大、胸痛气短——这些指向器质性疾病，任何养生方案都应该让位给医院
- 收益：避开"养生耽误病情"的最大坑
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：慢性疲劳诊疗指南中的危险信号列举（NICE、CDC）
- 备注：本书所有"调理"内容都以排除这些信号为前提

9. 养生调理的边界：非药物为主，中药必须面诊

- 成本：零
- 说人话：亚健康调理以生活方式干预为主；只有明确体质偏颇、经专业医师评估后，才考虑辅助调理。开中药必须望闻问切、辨证论治，看舌摸脉后开方——这是中医诊疗的法定要求，也是疗效和安全性的前提
- 收益：不踩"自服伤肝"的雷
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中华中医药学会《亚健康中医临床指南》（2020）干预原则；《中华人民共和国中医药法》
- 备注：网络问诊开方也必须是执业医师，且要看舌象照片等材料

10. 性价比总原则：先免费，后付费

- 成本：零
- 说人话：证据最硬、成本最低的干预——规律睡眠、适度运动、均衡饮食、限酒——全部免费；越往后越贵、证据越弱：功法课、推拿、补剂、保健品、仪器。钱应该按这个顺序花，而不是反过来
- 收益：一条排序挡掉大部分养生冤枉钱
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：本系列一贯框架；与官方科普口径一致（饮食、运动、睡眠是证据最充分的三项）
- 备注：本书第 11、12 节会把这个排序落到具体项目

11. 状态可以量化：两周疲劳日记

- 成本：每天 1 分钟
- 说人话：0–10 分给每天的疲劳度打分，同时记录睡眠时长、运动、压力事件、饮食和咖啡因。两周后你大概率能自己看出规律——是睡不够、压力峰值，还是久坐不动
- 收益：把模糊的"不得劲"变成可追踪的曲线，也是就医时最好的主诉材料
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：慢性疲劳管理中的活动与症状自我监测方法（NICE 推荐做法）
- 备注：过度记录本身造成焦虑，简单记几个数就行

12. 安慰剂效应与自愈：感觉好不等于有效

- 成本：零
- 说人话：人状态本身就会波动，加上安慰剂效应，任何干预做完都可能"感觉好了点"。判断一个方法值不值，看的是停用后是否维持、以及是否有对照研究——这也是本书给每条内容标证据等级的原因
- 收益：建立对"立刻见效"叙事的免疫力
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：循证医学基本方法（随机对照试验与安慰剂对照）
- 备注：注意另一面：安慰剂效应真实存在，不必为此羞愧，但别为它付高价

2. 疲劳自查，六类常见"累"法与对号入座

同样一句"累"，背后的机制完全不同，对策也完全不同。这一节给你一个自查框架：先给疲劳归因，再决定是看医生、改生活方式，还是找专业调理。

1. 自查流程：两周日记加六个问题

- 成本：零
- 说人话：记两周疲劳日记，再问自己六个问题：睡够了吗？压力大吗？动得少吗？伴不伴怕冷/口干/长痘等体质信号？用药时间对不对得上？情绪兴趣还在吗？多数人能自己对上号
- 收益：把"养生"变成"先诊断后干预"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：症状自评与就医主诉准备的常规方法
- 备注：对不上号、或伴随红旗信号，直接就医

2. 睡不够型：补觉能缓解的，就还不是病

- 成本：零
- 说人话：周末睡一觉就缓过来的累，大多是睡眠不足或睡眠质量差。对策是修复睡眠本身（固定作息、睡前断屏、限酒），而不是提神补剂
- 收益：认清最常见的疲劳原因
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：睡眠卫生的循证结论，见《睡眠》系列分册与睡眠医学会建议
- 备注：周末补觉别超过 1 小时，否则社交时相后移更难受

3. 压力型：心累，休息也不解乏

- 成本：零到低成本
- 说人话：持续压力让皮质醇高位运行，表现为"人躺下了脑子还在转"。这类疲劳靠睡觉补不回来，要靠减压手段：呼吸训练、运动、正念，以及真正减负（砍事项、谈边界）
- 收益：认清第二常见的疲劳机制
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：慢性压力与疲劳的机制综述；减压干预的 RCT 证据（见第 6 节）
- 备注：长期高压伴失眠、心悸，考虑心理咨询

4. 缺乏运动型：越不动越累

- 成本：零
- 说人话：长期不运动，身体会进入"省电模式"：心肺功能、肌肉量、线粒体效率全面下降，动一动就累。破局点恰恰是循序渐进地动起来——从每天 10 分钟快走开始
- 收益：把最反直觉的疲劳原因讲透
- 证据等级：A
- 风险：低（循序渐进前提下）
- 来源：运动生理学中的去适应（deconditioning）机制；WHO 身体活动建议
- 备注：注意：已确诊慢性疲劳综合征（ME/CFS）者不适用"多运动就好"，见本节第 11 条

5. 中医"气虚"型：气短、乏力、自汗的组合

- 成本：零
- 说人话：容易疲乏、气短懒言、动辄出汗、易感冒——中医归为气虚质，对应亚健康八型中的肺脾气虚、心脾两虚等。它的价值在于给出调理方向（健脾益气），但它同样可能是贫血、甲减的"马甲"，先排查再对号
- 收益：给一类常见疲劳一个传统框架的解释
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：中华中医药学会《亚健康中医临床指南》（2020）证型描述；GB/T 46939—2025 气虚质特征
- 备注：证型只是参考，最终以医师辨证为准

6. 内分泌型：怕冷、嗜睡、体重增加的"三件套"

- 成本：一次抽血
- 说人话：如果疲劳伴随怕冷、皮肤干、便秘、体重增加、声音嘶哑，先查甲功；伴随多饮多尿多食消瘦，查血糖。内分泌问题的疲劳，补品一律无效，纠正激素和血糖才有效
- 收益：快速锁定需医学处理的疲劳
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：《中国甲状腺功能减退症诊治指南》（2017）；糖尿病诊疗指南
- 备注：糖尿病前期的疲劳很常见，体检空腹血糖正常也别忽略糖化血红蛋白

7. 药物型：疲劳与用药时间对得上号

- 成本：零
- 说人话：他汀、β 阻滞剂、部分降压药、镇静类抗组胺药、含可待因的镇咳药都可能致疲劳。列一张用药时间线和疲劳曲线对照，和医生讨论调整
- 收益：零成本排查一类常被忽视的疲劳
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：药物不良反应监测的常规做法，见各药品说明书
- 备注：也包括"保健品叠吃"造成的相互作用

8. 情绪型：兴趣先消失，人后变累

- 成本：一次门诊
- 说人话：抑郁的疲劳有个特征：不是"不想动"，而是"曾经喜欢的一切都不想做了"，常伴早醒和晨重夜轻。这不是体质差，是情绪病，有循证治疗（心理治疗加必要时药物）
- 收益：把最不该被"养生"接走的疲劳分流到医院
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：抑郁障碍诊疗指南（中华医学会精神医学分会）
- 备注：有自伤念头时立即就医或拨打心理援助热线

9. 呼吸暂停型：打鼾、憋气、白天秒睡

- 成本：一次睡眠监测
- 说人话：别人看你睡觉"鼾声均匀、偶尔没声了"，而你白天开会都能睡着——高度提示睡眠呼吸暂停。缺氧是实打实的疲劳源，且独立升高高血压和心血管风险
- 收益：把一个慢性病拦在心血管事件之前
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：睡眠呼吸暂停诊疗指南
- 备注：体重下降 10% 常能显著改善中重度患者症状

10. 更年期型：潮热、盗汗、睡眠断裂

- 成本：一次妇科或更年期门诊
- 说人话：45－55 岁女性的疲劳加潮热、盗汗、月经紊乱、情绪波动，先考虑围绝经期。它有规范诊疗路径（激素治疗的获益风险评估、非激素方案），比"补气血"精准得多
- 收益：避免把生理过渡期当成"虚"来大补
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：绝经期诊疗指南（中华医学会妇产科学分会）
- 备注：男性也有"更年期"（迟发性性腺功能减退），但诊断要谨慎得多

11. 感染后型：病毒感染之后的"长疲劳"

- 成本：一次门诊排查
- 说人话：感冒、流感或其他病毒感染后，疲劳持续数周甚至数月，伴脑雾、活动后不适——近年最受关注的是 ME/CFS。注意：它的管理是" pacing（能量管理）"而不是"咬牙锻炼"，NICE 2021 已撤销分级运动疗法推荐
- 收益：避开对一类真实疾病最有害的建议
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：NICE 慢性疲劳指南（2021 更新）https://www.nice.org.uk/guidance/cg53 ；CDC ME/CFS 管理建议（2023）https://www.cdc.gov/me-cfs/
- 备注：先排除其他可治病因，再到相关专科

12. 对号入座之后的行动路线图

- 成本：零
- 说人话：睡不够型→修睡眠；压力型→减压三件套（呼吸/运动/减负）；不动型→循序渐进动起来；伴体质信号型→排查加辨证调理；对不上任何型、或伴红旗信号→就医。顺序不能反：先诊断，后养生
- 收益：一张路线图把六类疲劳各归其位
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：本系列"先诊断后干预"框架
- 备注：记住免费的三样永远排在付费的之前

3. 中医体质，九种体质与国标自评

中医调理的入口是"辨体"——先弄清自己是什么体质，再谈怎么调。2026 年这件事第一次有了国家标准。这一节把九种体质逐个讲清，也把自评的边界划清。

1. 体质是什么：疾病的"土壤"

- 成本：零
- 说人话：王琦院士的比喻：体质是疾病发生与发展的"内在基础"，像土壤。了解体质等于拿到一份"健康风险提示单"——痰湿质关注代谢病，血瘀质警惕心脑血管问题
- 收益：理解"为什么同样的生活方式，人和人反应不同"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：王琦院士中医体质学说，见 GB/T 46939—2025《中医体质分类与判定》及公开访谈（央广网，2026-02）
- 备注：体质学说有 40 万例流调支撑，但"体质→疾病风险"的因果证据仍在积累

2. 国标来了：从学会标准到国家标准

- 成本：零
- 说人话：《中医体质分类与判定》2009 年由中华中医药学会发布，2025 年 12 月升级为推荐性国家标准（GB/T 46939—2025），2026 年 4 月 1 日正式实施。国家中医药管理局起草，王琦院士领衔，15 年打磨
- 收益：体质辨识从"凭经验"变成有统一标尺的事
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025《中医体质分类与判定》，全国标准信息公共服务平台 https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D729455EE06397BE0A0ABB9A ；中国经济网 2026-02-28 报道
- 备注：适用于医疗、公卫、科研、教学和健康产业全领域

3. 27 题量表与 40 分判定法

- 成本：10 分钟
- 说人话：国标把辨识工具从 60 题精简到 27 题：回答典型体感问题，按等级计分，某类偏颇体质得分超过 40 分即判定为该体质。医院"治未病"科和正规体质辨识工具用的都是这套方法
- 收益：花十分钟拿到一份结构化自评
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025 判定方法；人民日报健康客户端 2026-04 报道
- 备注：简易量表只是基础参考，精准辨识仍要医师"望闻问切"

4. 平和质：九种里唯一的"理想型"

- 成本：零
- 说人话：阴阳气血调和，体态适中、面色红润、精力充沛、睡眠胃口都好。平和质不是"治"出来的，是规律作息、均衡饮食、适度运动、情绪稳定的综合结果——调养的终点就是靠近它
- 收益：认清养生的目标状态长什么样
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025 平和质特征表述
- 备注：纯正平和质的人不多，多数人是"平和夹一种偏颇"

5. 气虚质：易疲劳、气短、虚汗

- 成本：零
- 说人话：元气不足：容易疲乏、气短懒言、说话声音低、动辄出汗、易感冒，舌淡红、舌边有齿痕。调理方向是健脾益气——山药、大枣、小米等平补食材，加上规律运动
- 收益：最常见的疲劳体质对号入座
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025；《亚健康中医临床指南》（2020）肺脾气虚型
- 备注：先排查贫血和甲减——它们的表现高度重叠

6. 阳虚质：畏寒怕冷，手脚冰凉

- 成本：零
- 说人话：阳气不足：畏寒怕冷、四肢不温、喜热饮食、精神不振。调理方向是温阳——牛羊肉、生姜、胡椒等温性食物，避免生冷，注意腰腹足部保暖，适度日晒
- 收益：认清"怎么都暖不过来"的体质逻辑
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025；央广网 2026-02 科普解读
- 备注：甲减、贫血、雷诺现象都表现为怕冷，先排除

7. 阴虚质：口燥咽干，五心烦热

- 成本：零
- 说人话：阴液亏少：口燥咽干、手足心热、易失眠、大便干燥、舌红少苔。调理方向是滋阴——鸭肉、银耳、百合、绿豆、梨等甘凉食材，避免熬夜和辛辣燥热
- 收益：认清"上火又怕冷"的矛盾体质怎么吃
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025；人民日报健康客户端 2026-04 解读
- 备注：糖尿病、甲亢也有口干怕热，持续症状要查

8. 痰湿质：形体肥胖，困倦苔腻

- 成本：零
- 说人话：痰湿凝聚：体形偏胖、腹部肥满、面部油腻、容易困倦、口黏苔腻、易打鼾、大便黏。调理方向是健脾祛湿——少肥甘厚味和甜饮，多运动发汗，薏米、赤小豆、冬瓜等食疗辅助
- 收益：把"喝水都胖"和减重逻辑接上
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025；与《减重》分册的痰湿质肥胖干预衔接
- 备注：痰湿质是代谢综合征高危体质，腰围和血糖血脂要定期看

9. 湿热质与血瘀质：长痘口苦和色暗长斑

- 成本：零
- 说人话：湿热质：面垢油光、易生痤疮、口苦口干、大便黏滞——宜清淡、少辛辣甜腻、忌熬夜。血瘀质：肤色晦暗、易现瘀斑、健忘急躁——宜运动活血、少久坐，控制烟酒
- 收益：两类常见偏颇体质的识别与方向
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025 湿热质、血瘀质特征
- 备注：长期"上火"伴口苦，也要排查肝胆和胃食管问题

10. 气郁质：情绪低落，敏感多虑

- 成本：零
- 说人话：气机郁滞：情绪低落、紧张焦虑、敏感多虑、胸胁胀满、善太息。调理方向是疏肝理气——户外活动、社交、兴趣爱好，必要时专业心理支持；闷坐和熬夜是两大加重因素
- 收益：把"情绪型疲劳"和体质框架接上
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025；《亚健康中医临床指南》（2020）肝气郁结型
- 备注：持续两周以上情绪低加兴趣丧失，按第 1 节流程就医

11. 特禀质：过敏体质与先天失常

- 成本：零
- 说人话：先天失常、过敏反应：易患哮喘、荨麻疹、花粉症，药物食物过敏史，皮肤易起抓痕。这类体质"调"的空间有限，重点是规避过敏原、规范用药、发作时规范治疗
- 收益：认清一类"不该硬调"的体质
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025 特禀质特征
- 备注：严重过敏（如过敏性休克史）要随身备药并定期复诊

12. 体质不是一成不变，自评更不能替代面诊

- 成本：零
- 说人话：王琦院士明确提醒：体质会随生活环境、饮食、作息、运动而动态变化——熬夜、换城市生活都可能改变体质。自评量表只是"基础参考"，精准辨体、定制调理方案，必须去正规中医院由医师四诊合参
- 收益：既会用国标工具，又知道它的边界
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：GB/T 46939—2025 宣贯报道（央广网、人民日报健康客户端，2026）
- 备注：别拿自评结果去电商搜"气虚吃什么"——那正是营销话术的入口

4. 亚健康八型辨证，指南怎么说

中华中医药学会《亚健康中医临床指南》（2020）把亚健康分为八个证型，每个证型有对应的经典方剂。这一节把八个型讲清楚——更重要的是讲清楚：方剂是给医生看的，不是给你照着抓药的。

1. 八型辨证总览：先辨病，再辨证

- 成本：零
- 说人话：指南把亚健康分为八型：肝气郁结、肝郁脾虚、心脾两虚、肝肾阴虚、肺脾气虚、脾虚湿阻、肝郁化火、痰热内扰。它们分别对应胸胁胀闷情绪差、累加消化不良、心慌失眠没胃口、腰酸烦热、气短易感冒、身重困倦、急躁口苦、心烦失眠便秘等不同组合
- 收益：建立"亚健康不是一种虚，而是八种不同失调"的框架
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：中华中医药学会《亚健康中医临床指南》（2020）；好大夫在线刊载的指南解读
- 备注：八型只是常见分型，临床还有兼夹；辨证必须由医生做

2. 肝气郁结型：胸胁满闷，情绪低落

- 成本：零（识别）
- 说人话：表现是胸胁满闷、喜太息、周身窜痛、时发时止、情绪低落或急躁易怒、咽喉异物感（梅核气）、月经不调，脉弦。指南用柴胡疏肝散加减
- 收益：认清"气出来的病"长什么样
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：《亚健康中医临床指南》（2020）
- 备注：和焦虑抑郁的躯体化高度重叠，持续情绪低落请先按第 1 节就医

3. 肝郁脾虚型：累，加上消化乱

- 成本：零（识别）
- 说人话：在肝气郁结基础上加周身倦怠、神疲乏力、食欲不振、脘腹胀满、便溏不爽，脉弦细。指南用逍遥散加减——这是亚健康里最常见的一型，情绪影响消化
- 收益：认清"一紧张就胃不舒服犯懒"的机制
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：《亚健康中医临床指南》（2020）
- 备注：肠易激综合征常挂在这型下面，先看消化科排除器质病

4. 心脾两虚型：心慌、失眠、没胃口

- 成本：零（识别）
- 说人话：心悸胸闷、气短乏力、自汗、头晕头昏、失眠多梦、食欲不振、腹胀便溏，舌淡苔白、脉细弱。指南用归脾汤加减——思虑过度、用脑过度者的典型状态
- 收益：认清"心累"型疲劳
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：《亚健康中医临床指南》（2020）
- 备注：真正的心慌要查心电图和甲功，别默认是"虚"

5. 肝肾阴虚型：腰膝酸软，烦热盗汗

- 成本：零（识别）
- 说人话：腰膝酸软、疲乏无力、眩晕耳鸣、失眠多梦、烘热汗出、潮热盗汗、月经不调、遗精早泄，舌红少苔、脉细数。指南用知柏地黄丸加减
- 收益：认清"透支型"状态
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：《亚健康中医临床指南》（2020）
- 备注：长期盗汗加消瘦，要排查结核、甲亢等

6. 肺脾气虚型：气短自汗，反复感冒

- 成本：零（识别）
- 说人话：胸闷气短、疲乏无力、自汗畏风、易于感冒、食欲不振、腹胀便溏，舌淡苔白、脉细弱。指南用玉屏风散合四君子汤加减——"扶正固本"说的就是这类
- 收益：认清"免疫力差"的中医框架
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：《亚健康中医临床指南》（2020）
- 备注：反复感冒先查血常规和免疫指标

7. 脾虚湿阻型：身重困倦，嗜睡

- 成本：零（识别）
- 说人话：神疲乏力、四肢困重、困倦多寐、食欲不振、腹胀便溏、面色萎黄，舌淡苔白腻、脉沉细。指南用平胃散合参苓白术散加减——"湿气重"的教科书描述
- 收益：认清"怎么睡都困"的体质背景
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：《亚健康中医临床指南》（2020）
- 备注：打鼾严重加白天嗜睡，先查睡眠呼吸暂停（第 1 节）

8. 肝郁化火型与痰热内扰型：急躁口苦和心烦便秘

- 成本：零（识别）
- 说人话：肝郁化火：头胀头痛、眩晕耳鸣、胸胁胀满、口苦咽干、失眠多梦、急躁易怒、舌红苔黄、脉弦数，用龙胆泻肝散加减。痰热内扰：心悸心烦、焦虑不安、失眠多梦、便秘、舌红苔黄腻，用温胆汤加减
- 收益：两类"上火型"亚健康的识别
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：《亚健康中医临床指南》（2020）
- 备注：龙胆泻肝散中的木通有肾毒性争议，含马兜铃酸复方已禁用——更说明不能自服

9. 为什么不能照着方子自己抓药

- 成本：零
- 说人话：第一，八型之间会兼夹（肝郁脾虚就是兼夹），证候随时变化，方剂要随证加减；第二，经典方里的药材有毒性边界——何首乌、土三七、雷公藤都有明确肝损病例，关木通、广防己含马兜铃酸已被禁用；第三，同样的方对不同人效果和风险完全不同
- 收益：避开养生最贵的一刀：自服中药
- 证据等级：A
- 风险：低（规避风险本身就是收益）
- 来源：国家药品监督管理局何首乌等药材安全性公告；《中华人民共和国中医药法》
- 备注：中成药也是药，"OTC"不等于"可以随便长期吃"

10. 看中医的合规路径

- 成本：一次门诊几十到几百元
- 说人话：正规路径：正规医疗机构（中医院或综合医院中医科）→ 执业医师望闻问切 → 辨证开方 → 复诊调方。疗程以 3 个月为一个评估阶段，无效就要重新评估，而不是无限续方
- 收益：把"调理"纳入可评估的轨道
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：《亚健康中医临床指南》（2020）干预原则；《中医药法》
- 备注：网络问诊同样必须是有资质平台的执业医师，且要看舌脉资料

11. 中成药与养生产品的营销拆解

- 成本：零
- 说人话：电商上"气虚吃XX丸""湿气喝XX膏"的话术，共同点是：把辨证结论直接卖给你、把复方加减简化成单品、把疗程包装成日常消费品。真正的中医是"一人一方、随证加减"，和货架逻辑天然矛盾
- 收益：看清养生产品的商业本质
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：广告法与保健食品营销监管的公开执法案例；市场监管总局《保健食品标注警示用语指南》（2019）
- 备注：看到"一人一方"被做成标准sku，就要提高警惕

12. 这一节的正确用法

- 成本：零
- 说人话：八型辨证的正确用法是：当"症状字典"用——让你和医生沟通时更准确（"我疲劳加消化不良加情绪低落，像肝郁脾虚"）；不是当"购药指南"用。任何调理之前，先走完第 1 节的排查
- 收益：用指南而不被指南滥用
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：本系列"先诊断后干预"框架
- 备注：如果医生只说三分钟就开一个月的代煎药，可以换一家

5. 传统功法，证据相对最好的一类

八段锦、太极拳、五禽戏这类传统功法，是中医体系里少有的被大量随机对照试验反复验证的干预。它们的性价比极高——零成本、零器械、随处可练——但证据质量整体偏弱，这一节把好处和局限都讲清。

1. 功法是什么：慢、连、匀、静的身心运动

- 成本：零
- 说人话：八段锦（八个动作）、二十四式太极拳、五禽戏（模仿虎鹿熊猿鸟）、六字诀（吐纳发音），共同点是动作缓慢、连绵不断、配合呼吸和意念。属于"身心运动"，和瑜伽同类
- 收益：认清这一类干预的定义和边界
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：《中国纤维肌痛综合征诊疗指南》（2023）将传统功法列为运动干预形式
- 备注：国家体育总局有简化套路的官方教学资源，免费

2. 对慢性疲劳的 meta 分析：有效但文献质量偏低

- 成本：零
- 说人话：《中医药导报》2020 年一篇 meta 分析汇总了功法干预慢性疲劳综合征的试验：身体疲劳积分下降约 5.1 分、睡眠质量指数下降 0.83、焦虑下降 0.87、抑郁下降 1.62，均优于对照组。但作者自己指出：纳入文献质量较低，尤其缺乏分配隐藏和盲法，需要更高质量研究证实
- 收益：知道它"可能有效"，也知道证据的成色
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：刘琴等. 功法治疗慢性疲劳综合征的 Meta 分析. 中医药导报, 2020, 26(6):64-70
- 备注：功法研究很难盲法——受试者知道自己练的是太极，这是天然的局限

3. 八段锦的 meta：覆盖面最广的一类证据

- 成本：零
- 说人话：2026 年 Frontiers in Psychology 一篇 meta 汇总了 36 项 RCT、3200 余名大学生：八段锦对抑郁、焦虑、压力、负面情绪、疲劳和睡眠质量均有统计学改善。但两个重要提醒：睡眠和压力的改善在停止练习后不持续；整体方法学质量为中等
- 收益：证据版图最大的一项，同时看清"停练就退"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：Chen J, et al. Frontiers in Psychology, 2026（PMID 42220380）
- 备注：推论：功法是"长期饭票"，不是"一疗程解药"

4. 指南推荐：纤维肌痛和慢病人群

- 成本：零
- 说人话：《中国纤维肌痛综合征诊疗指南》（2023）明确推荐患者运动锻炼，形式包括有氧、力量、传统功法（太极、八段锦、六字诀、五禽戏）、瑜伽等，疗程至少 3 个月。一项 13 篇 RCT 的 meta 显示功法练习（中位 60 分钟/次、12 周）可改善疼痛、疲劳、抑郁、睡眠，疗效可维持到 24–52 周
- 收益：从"民间健身"升级为"指南推荐"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：《中国纤维肌痛综合征诊疗指南》（2023）及所引 meta 分析
- 备注：注意推荐对象是"稳定期患者"，不是所有人

5. 癌因性疲劳：八段锦证据最强的人群

- 成本：零
- 说人话：一篇纳入 23 项 RCT、1730 例乳腺癌患者的身心运动 meta 显示：八段锦降低疲乏效果最强（SMD=-0.91），太极拳次之（-0.57），瑜伽不显著；焦虑抑郁也有改善，但对睡眠质量的改善未达统计学意义
- 收益：疲劳证据最硬的具体场景
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：身心运动对乳腺癌患者干预效果的 Meta 分析（中华医学期刊）
- 备注：肿瘤患者练前仍需经主治医生评估

6. 八段锦入门：十二式从哪式开始

- 成本：零
- 说人话：最出名的是第二式"双手托天理三焦"——伸懒腰式的全身拉伸。入门不必记全十二式，先学三式：双手托天（拉伸）、调理脾胃须单举（躯干侧屈）、摇头摆尾去心火（核心放松），跟官方视频练，每次 12–15 分钟
- 收益：把"想练"变成"能开始"
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：国家体育总局《健身气功·八段锦》简化教材
- 备注：动作慢比动作对更重要，呼吸自然别憋气

7. 太极拳：二十四式是性价比之选

- 成本：零到低（可自学）
- 说人话：二十四式简化太极拳是入门标准套路，学完约 20–30 小时（线下班几百元，或跟免费视频自学）。它的独特价值是"单腿转移重心"大量训练平衡能力——老年人防跌倒是硬证据
- 收益：一份投入，抗疲劳和防跌双收
- 证据等级：B
- 风险：低（膝盖旧伤者注意蹲姿幅度）
- 来源：太极拳改善平衡与防跌倒的 RCT 证据综述
- 备注：膝盖不好选蹲姿浅的练法，或改练八段锦

8. 怎么练才有效：频率、时长、周期

- 成本：零
- 说人话：证据里有效的方案大致是：每周 3–5 次、每次 20–60 分钟、持续 12 周以上。低于这个剂量效果打折；大学生 meta 的亚组分析还提示每周 3 次对整体心理健康可能就够了
- 收益：把"练了没用"变成"剂量不够"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：八段锦 meta（2026）亚组分析；纤维肌痛指南疗程建议
- 备注：每天 12 分钟八段锦比每周一次 90 分钟更符合证据

9. 功法的风险：膝盖、头晕和呼吸

- 成本：零
- 说人话：三类常见问题：马步蹲太低伤膝；起势转体太快头晕（尤其是低血压和服药者）；刻意深呼吸导致过度换气（头晕手麻）。对策：蹲姿不过脚尖、动作宁慢勿快、呼吸自然
- 收益：避开功法仅有的几个坑
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：运动损伤与呼吸性碱中毒的临床常识；NSDR 等呼吸训练安全提示
- 备注：头晕时立刻停止、正常呼吸几分钟

10. 功法 vs 健身房：性价比对比

- 成本：零
- 说人话：健身房年卡加私教几千元、通勤时间另算；功法零成本、居家可练、对关节冲击小。但论增肌、骨密度和心肺峰值，力量和有氧训练证据更硬。结论：状态调理选功法，体能建设还得练力量——两者互补不互斥
- 收益：把钱和时间花在对的地方
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：与《运动》分册的循证结论衔接
- 备注：中老年人平衡训练优先，年轻人别用功法替代力量训练

11. 为什么功法证据整体偏弱

- 成本：零
- 说人话：三个结构性原因：无法盲法（知道自己练什么）、对照组难设（"假八段锦"不好设计）、发表偏倚（国内阳性结果更容易发）。这不是中医独有的问题，是身心干预共同的方法学困境
- 收益：建立对"国潮养生"证据成色的合理预期
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：补充与替代医学研究方法学综述（如 EBSCO 循证评述）
- 备注：证据等级 B 的意思是"可能有用"，不是"确证有用"

12. 结论：性价比极高，但别指望神效

- 成本：零
- 说人话：综合所有证据：功法对疲劳、情绪、压力的改善方向一致，量级为小到中，安全性好，成本为零——按本书标准就是"极高性价比"。但它是慢变量：以月计、停练退、不治病。把它当长期基建，不当急救药
- 收益：对功法的一个理性定位
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：本节全部证据综合
- 备注：如果只从这本书执行一件事，练八段锦

6. 呼吸与放松，最便宜的状态工具

深呼吸、正念、肌肉放松——这些零成本、随时可做的小工具，是压力型疲劳的对症解。这一节讲清每一样有多少证据、怎么练、以及它们的共同局限：都是调节，不是治疗。

1. 压力为什么让人累：交感神经的油门松不下来

- 成本：零
- 说人话：持续压力让身体保持在"应战"状态：心率快、皮质醇高、肌肉紧、睡眠浅。放松类训练的共同原理是反过来——激活副交感神经，把油门松掉。这类疲劳的特点正是"躺着也累"
- 收益：理解放松训练不是玄学是生理
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：自主神经与应激的生理学共识
- 备注：减压的根源是减压力源，训练只是对冲

2. 腹式呼吸：最基础也最好上手

- 成本：零
- 说人话：一手放胸一手放腹，吸气时让肚子鼓起来、胸不动，呼气比吸气长。每天 5 分钟。一项 40 人的试验显示 8 周腹式呼吸训练改善了持续注意力并降低皮质醇
- 收益：随时随地可做的压力刹车
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：Ma X, et al. 2017（8 周腹式呼吸试验）；NHS 呼吸练习建议
- 备注：别用力过猛——头晕就是过度换气的信号

3. 呼吸训练的 meta：有效但别高估

- 成本：零
- 说人话：2023 年一篇 meta 分析（12 项 RCT、785 人）显示呼吸训练降低自评压力，效应量约 0.35（小到中）；20 项试验显示降焦虑约 0.32。作者明确警告："宣传热度与证据之间存在校准失衡"——多数试验偏倚风险中等
- 收益：拿到证据的同时不被夸大叙事带跑
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：Fincham G, et al. 2023（呼吸训练 meta 分析）
- 备注：作者原话提醒 hype 与 evidence 的错位

4. 一个反例：纠结"每分钟几次"可能没意义

- 成本：零
- 说人话：迄今最大的呼吸试验（400 人）发现：每分钟约 5.5 次慢呼吸组和每分钟 12 次的常规组，改善程度没有差别——两组都改善了。结论：每天练 10 分钟这个"行为"本身，比具体呼吸频率重要
- 收益：放过自己，别在参数上焦虑
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：Fincham 2023 meta 所引的 400 人试验
- 备注：各种"网红呼吸法"的差异，证据不支持神话任何一种

5. 4-7-8 呼吸：助眠向，别当万能药

- 成本：零
- 说人话：吸气 4 秒、屏息 7 秒、呼气 8 秒，由哈佛医学院 Weil 医生推广，定位是"睡前放松"。延长呼气确实激活副交感，但"4-7-8 治失眠"没有高质量证据；屏息 7 秒觉得憋的人，保持 4:7:8 的比例把数字缩小即可
- 收益：会用一个流行的助眠工具，也知道它的成色
- 证据等级：C
- 风险：中（屏息类呼吸不适合所有人，见本节第 11 条）
- 来源：Weil 的原始推广资料；NSDR 等呼吸法安全性评述
- 备注：孕妇、高血压、青光眼、癫痫史者避免屏息式

6. 生理叹息：两次吸气一次长呼气

- 成本：零
- 说人话：鼻吸一口气、再补吸一小口，然后用嘴缓缓长呼出去——这是人体本能的叹气机制放大版。适合会议间隙、演讲前、情绪上头的瞬间，一两分钟即可，不用计数、不用场地
- 收益：一个"立刻能用"的应急工具
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：Huberman 等科普传播的呼吸技术；对应生理机制为叹气反射
- 备注：证据级别低，但作为零成本应急手段值得备着

7. 正念减压（MBSR）：八周课程是标准剂量

- 成本：零到低（有免费音频课程）
- 说人话：卡巴金创立的正念减压疗法，标准剂量是 8 周、每周 2.5 小时课程加每日 45 分钟练习。对焦虑、抑郁、压力相关躯体症状有一致证据；2019 年一项 RCT 显示 8 周 MBSR 对广泛性焦虑的效果持续到干预后 12 周
- 收益：压力型疲劳证据最硬的心理工具
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：Kabat-Zinn 团队研究；2019 年《美国精神病学杂志》RCT 及 2020 年 meta 分析
- 备注：日常简化版：每天 10 分钟"身体扫描"或呼吸觉察，有效但别期待等同完整课程

8. 渐进式肌肉放松：从头到脚紧绷再放松

- 成本：零
- 说人话：从脚趾开始，逐组肌肉绷紧 5–7 秒、再彻底放松 10–15 秒，一路到头。对"身体一直紧着"的人（肩颈硬、咬牙、攥拳）特别对症。睡前做 10 分钟助眠效果明确
- 收益：把"不知道自己紧张"变成"能主动放松"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：放松训练的经典方案，见失眠 CBT-I 的组成部分
- 备注：和腹式呼吸组合成 10 分钟睡前流程效果更好

9. 5-4-3-2-1 感官接地：急性焦虑的急救

- 成本：零
- 说人话：说出 5 个看到的、4 种摸到的、3 种听到的、2 种闻到的、1 种尝到的——用感官刺激把注意力从恐慌念头拉回当下。用于惊恐发作、考前恐慌、深夜思维反刍的当场缓解
- 收益：一个随身携带的"暂停键"
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：grounding 技术，见焦虑障碍自助的常规推荐
- 备注：急救有效不等于治本，反复发作要就医

10. 每天 10 分钟的性价比

- 成本：零
- 说人话：所有试验里有效剂量都不大：腹式呼吸每天 5 分钟、正念简化版 10 分钟、肌肉放松睡前 10 分钟。合计 10–20 分钟，是本书里性价比最高的一类时间投资
- 收益：把"没时间养生"这个借口拆掉
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：本节各项试验的最小有效剂量
- 备注：固定时间比时长重要——绑定在已有习惯上（如饭后、睡前）

11. 谁要小心：屏息类呼吸的禁忌

- 成本：零
- 说人话：含屏息的呼吸法（4-7-8、箱式呼吸）不适合：高血压控制不佳者、青光眼、癫痫病史、孕妇、严重精神疾病史者——屏息会升压、升眼压、有诱发风险。这类人群用纯腹式呼吸（无屏息）即可
- 收益：避开放松训练里唯一像样的风险
- 证据等级：B
- 风险：低（规避风险）
- 来源：斯坦福呼吸试验的排除标准及 NSDR 安全性评述
- 备注：试验中约 10% 受试者报告过负面体验——不适应就换方法

12. 结论：它们是刹车，不是发动机

- 成本：零
- 说人话：呼吸和放松训练对"压力型疲劳"有效，量级小到中；它们不能治疗焦虑症、抑郁症，也不能替代睡眠和运动。正确期待：每天几分钟，把身体的油门松一松——这件事本身有价值
- 收益：给零成本工具一个诚实定位
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：本节证据综合
- 备注：症状持续加重时，心理咨询和医疗干预才是主线

7. 穴位按摩与推拿，有证据的与没有的

按摩和穴位是养生消费的大头，也是话术最密集的地带。这一节的思路：把"放松肌肉"的有效部分和"调理脏腑"的存疑部分切开，各自给一个诚实定位。

1. 经络穴位的中医框架：一张地图，两套验证

- 成本：零
- 说人话：中医认为经络是气血运行的通道，穴位是通道上的调节点；现代研究则用"神经-筋膜-免疫"另一套语言解释穴位刺激。两套框架各自能解释一部分现象，但后者还没能把"穴位特异性"完整证实
- 收益：理解为什么穴位疗效总是"有但有争议"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：针灸与穴位研究的机制综述；WHO 传统医学术语文件
- 备注：本节的策略：区分"可以安全自用的放松手段"和"需要专业操作的医疗行为"

2. 足三里、三阴交、太冲：名气最大的三个

- 成本：零
- 说人话：足三里（膝下四横指）号称"强壮穴"，关元（脐下三寸）补元气，三阴交（内踝上四横指）调脾肝肾，太冲（足背）疏肝。中医典籍和养生内容对它们的功效描述高度一致，但现代试验的证据质量参差、样本普遍偏小
- 收益：认识三个可以安全自按的穴位
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：《经络腧穴学》教材；穴位刺激的临床研究综述
- 备注：按揉 3–5 分钟/次、有酸胀感即可，别按到疼

3. 穴位按压的证据现状：方向友好，成色有限

- 成本：零
- 说人话：穴位按压的研究绝大多数是小样本 RCT，阳性结果多但重复性差，而且很难排除安慰剂（患者知道自己被按的是"有效穴"）。对恶心、痛经、失眠等有一致性不高的改善报告
- 收益：建立对穴位疗效的合理预期
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：穴位按压的系统评价（样本量小、偏倚风险高）
- 备注：把它当"可能有点用的免费手段"，不当"治疗"

4. 自我按摩：安全、免费，值得保留

- 成本：零
- 说人话：按揉足三里、太阳穴、肩颈酸痛点——即使穴位特异性存疑，按压本身有明确的生理效果：放松肌肉、促进局部血流、打断"紧张-疼痛"循环。作为工间放松手段，它比离开工位更容易执行
- 收益：零成本拿到"放松"这部分确定收益
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：按摩放松肌肉骨骼的循证结论（物理治疗常规）
- 备注：酸痛点（阿是穴）按 30 秒松开，反复 3–5 次

5. 推拿的肌肉骨骼证据：短期缓解颈肩腰背痛

- 成本：每次几十到几百元
- 说人话：对颈肩腰背的肌肉筋膜疼痛，推拿有短期缓解证据（和热敷、牵引、运动疗法同属物理治疗范畴）。证据量级不大，但对久坐人群的肩颈僵硬是实用的对症手段
- 收益：把推拿放回它有效的位置
- 证据等级：B
- 风险：中（操作不当时）
- 来源：推拿治疗慢性颈肩腰背痛的系统评价
- 备注："短期缓解"意味着它治标不治本，运动训练才是治本

6. 推拿的风险：暴力正骨和脊髓损伤

- 成本：零
- 说人话：非医疗机构常见的"咔咔正骨"有真实风险：暴力扭转颈椎可能损伤椎动脉或脊髓，严重可致瘫痪。凡出现"当场缓解、随后手麻头晕"都要立刻就医。正规推拿前应询问肿瘤、骨折、凝血障碍、妊娠禁忌
- 收益：避开推拿唯一但最重的坑
- 证据等级：A
- 风险：高（对不当操作）
- 来源：脊柱推拿不良事件的病例报告与监管警示
- 备注：绝对不去"养生馆"做颈椎胸椎的暴力扳转

7. 筋膜枪和按摩仪：有效的是"按压"，不是"科技"

- 成本：几百元
- 说人话：筋膜枪的实质是高频按压加震动，对放松肌肉有一定帮助，但它不"松筋膜"、不"排乳酸"、更不能减肥（局部震动不减少该部位脂肪）。同一块肌肉自己按或滚泡沫轴，效果接近
- 收益：少买一件吃灰器械
- 证据等级：C
- 风险：中（对着颈前、腋下、关节、腹部打有风险）
- 来源：筋膜枪研究的有限证据；运动医学对震动放松的评估
- 备注：颈部和内脏部位禁用，单点不超过 2 分钟

8. 自己按 vs 技师按：性价比账

- 成本：零 vs 每次 100–500 元
- 说人话：自我按压拿到"放松肌肉"这个核心收益；技师的价值在于覆盖自己按不到的部位（肩胛骨内侧、下背）和更到位的力度。结论：日常自己按，偶尔技师按，别形成依赖性的高频消费
- 收益：把推拿从"定期打卡"降级为"偶尔对症"
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：基于疗效证据的性价比排序（本系列框架）
- 备注：一周三次推拿还治不好的肩颈，答案通常在工作姿势和运动里

9. 怎么选正规机构：资质、禁忌、话术

- 成本：零
- 说人话：三看：看机构是否医疗机构（牌匾写"诊所/门诊部"而非"养生馆/SPA"）、看技师资质（医师资格或职业技能证书）、看是否主动问禁忌。三不问：不问"湿气重不重"、不办预付卡、不信"一次见效包治"
- 收益：把养生消费的风险控制住
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：《中医药法》与医疗机构执业管理规定
- 备注：预付卡跑路是养生行业高发纠纷，警惕年卡诱惑

10. 哪些人不能推拿和重按

- 成本：零
- 说人话：禁忌清单：骨折和骨质疏松严重者、肿瘤（尤其骨转移）、凝血障碍或服抗凝药、皮肤破损感染、孕妇（尤其腰腹和部分穴位）、严重心脑血管病急性期、醉酒空腹。有这些情况，技师应主动拒绝
- 收益：一张保命清单
- 证据等级：A
- 风险：高（对违反禁忌的操作）
- 来源：推拿禁忌的临床共识；《中医养生保健技术操作规范》（2010）
- 备注：技师不问禁忌就上手，本身就是危险信号

11. 穴位不能"排毒"，也没有"通则不痛"的神话

- 成本：零
- 说人话："按出淤青是排毒""经络不通万病之源"都是营销话术：淤青是皮下出血，和排毒无关；疼痛缓解更可能来自肌肉放松和期望效应。身体没有"经络毒素"这种东西
- 收益：拆掉两个最常见的营销概念
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：官方科普辟谣口径（人体代谢废物的排出依靠肝肾，见第 12 节）
- 备注：同理：刮痧拔罐的颜色深浅也不是"毒"

12. 结论：放松有效，调理证据不足

- 成本：零
- 说人话：这一节的总结：穴位自我按压和推拿的价值主要在"放松肌肉、缓解紧张"——这部分真实、可及；"按穴位治脏腑病"——证据不足，别当治疗；暴力操作是真实风险，坚决避开
- 收益：给按摩类消费一个清晰边界
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：本节证据综合
- 备注：按这个标准，每年在按摩上的花费应该大幅下降

8. 外治法，艾灸拔罐刮痧与足浴

艾灸、拔罐、刮痧、足浴是"养生馆四大件"。官方对它们的定位写得很清楚：养生保健技术，适用于缓解疲劳和肌肉酸痛等亚健康状态，不用于疾病治疗。这一节把各自的证据和边界讲清。

1. 官方定位：保健技术，不是治疗手段

- 成本：零
- 说人话：国家中医药管理局《中医养生保健技术操作规范》（2010）把刮痧、拔罐等列为中医养生保健技术，适用范围明确为"缓解疲劳、肌肉酸痛等亚健康状态，不用于疾病治疗"。这句话是整个行业的法律边界，也是判断话术的标尺
- 收益：一条官方定义挡住一半养生馆推销
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：国家中医药管理局《中医养生保健技术操作规范》（2010）
- 备注：任何宣称这些手段"治病"的机构，都在越界宣传

2. 艾灸：温热效应明确，疗效证据温和

- 成本：每次几十到几百元，或自购艾条几十元
- 说人话：艾灸的温热刺激对怕冷、腹凉、关节僵的人有舒适感，部分小样本试验显示对寒性疼痛、疲劳有改善。但证据整体质量不高，且它有独特风险——烫伤（尤其是感觉减退者和睡眠中）
- 收益：认清"老祖宗智慧"的证据成色
- 证据等级：C
- 风险：中（烫伤、烟雾吸入）
- 来源：艾灸临床研究的系统评价（小样本、质量参差）
- 备注：糖尿病周围神经病变者、皮肤感觉差者、孕妇腰腹禁用

3. 拔罐：有 RCT，证据低到中等

- 成本：每次几十到上百元
- 说人话：2020 年 BMJ Open 一篇系统评价汇总了 135 项拔罐 RCT：对慢性颈肩痛、腰背痛有短期缓解的报告，但多数试验方法学质量偏低，证据等级为低到中等。它缓解的是肌肉骨骼疼痛，且是短期的
- 收益：拿到拔罐最权威的一份证据体检报告
- 证据等级：B
- 风险：中（皮肤损伤、感染、禁忌人群）
- 来源：Cupping 系统评价, BMJ Open, 2020（135 项 RCT）
- 备注：拔罐对高血压、失眠、减肥的宣传均无可靠证据

4. 罐印深=毒多？这是拔罐最大的谎言

- 成本：零
- 说人话：罐印颜色只取决于负压大小、留罐时间、个人毛细血管脆性，和"湿气""毒素"没有任何对应关系。有人拔完紫黑，有人几乎无印——这只是皮肤差异。把罐印当疗效指标，是营销的核心话术
- 收益：拆穿一个流传最广的养生骗局
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：负压造成毛细血管破裂的机械机制（临床共识）
- 备注：技师如果拿罐印给你"解读病情"，换一家

5. 刮痧：局部刺激，辅助放松

- 成本：每次几十元，或自购刮痧板十几元
- 说人话：刮痧通过摩擦刺激皮肤和浅层肌肉，暂时增加局部血流，对运动后酸痛、久坐肩颈僵硬有缓解作用，持续数小时到数天。但"痧色越深效果越好"不成立，过度刮拭反而损伤皮肤
- 收益：认清刮痧的真实作用范围
- 证据等级：C
- 风险：中（皮肤破损、感染）
- 来源：《中医养生保健技术操作规范》（2010）；刮痧临床研究（小样本为主）
- 备注：同一部位间隔 3–5 天再操作，避开破损和炎症皮肤

6. 外治法共同的禁忌人群

- 成本：零
- 说人话：孕妇（腰腹和部分穴位绝对禁止）、凝血功能障碍和服抗凝药者、皮肤破损或感染、严重心脑血管病急性期、高热、恶性肿瘤、空腹或过饱、极度疲劳。正规场所操作前必须评估这些
- 收益：一张通用的安全清单
- 证据等级：A
- 风险：高（对违反禁忌的操作）
- 来源：《中医养生保健技术操作规范》（2010）禁忌条款
- 备注：在家自行拔罐刮痧很难控制消毒和力度，是最常见的事故场景

7. 足浴和泡脚：便宜、安全、放松有效

- 成本：一个桶，几十元
- 说人话：40℃ 左右温水泡脚 15–20 分钟，是外治法里性价比最高的一项：温热扩张外周血管、放松肌肉、改善入睡前的"身体放松度"。它不能治百病，但作为睡前放松流程安全有效
- 收益：用最低成本拿到"放松入睡"收益
- 证据等级：B
- 风险：低（水温过高有风险）
- 来源：温热放松对睡眠潜伏期的改善证据；足浴研究的系统评价
- 备注：糖尿病周围神经病变、下肢静脉血栓、严重心衰患者慎用高温长时间泡脚

8. 汗蒸和桑拿：放松可以，排毒减重是假的

- 成本：每次几十元
- 说人话：汗蒸的本质是热刺激加放松，和泡澡同类。出的是汗和水，不是"毒"——人体排毒靠肝肾。减掉的是水，喝水就回来。心血管病患者、孕妇、饮酒后进汗蒸房有明确风险
- 收益：避开"蒸一蒸百病消"的营销
- 证据等级：B
- 风险：中（脱水、低血压、心血管事件）
- 来源：温热疗法与"排毒"的官方辟谣口径（见第 12 节）
- 备注：单次不超过 20 分钟，出来后补水

9. 三伏贴：理论丰富，证据温和

- 成本：每伏数百元
- 说人话："冬病夏治"的三伏贴在呼吸系统慢病的维持治疗中有一些小样本支持，但证据质量不高，且皮肤起疱是常见"疗效"——本质是化学性刺激。把它当传统习俗可以，当治疗手段不够格
- 收益：认清节气养生的证据位置
- 证据等级：C
- 风险：中（皮肤灼伤、过敏）
- 来源：三伏贴临床研究的系统评价（证据有限）
- 备注：起疱不是"排病"，是皮肤损伤，感染要就医

10. 家用拔罐器的自用风险

- 成本：零
- 说人话：电商家用拔罐器的问题集中在三点：消毒不达标（多人混用）、留罐时间过长（超过 10 分钟易起水疱）、在脊柱和胸腹等危险部位操作。真想自己用：一人一套器具、留罐 5 分钟内、只用在肌肉厚的肩背四肢
- 收益：把自用风险压到最低
- 证据等级：B
- 风险：中
- 来源：《中医养生保健技术操作规范》（2010）留罐时间要求；拔罐不良事件报告
- 备注：出现水疱按烫伤处理：别挑破，防感染

11. 频率与理性预期

- 成本：零
- 说人话：即使要做，频率也有谱：同一部位刮痧间隔 3–5 天、拔罐 5–7 天，让皮肤恢复。每周两三次拔罐刮痧属于过度消费——皮肤还没修好又损伤一遍
- 收益：把"上瘾式养生"拉回常识
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：操作规范中的间隔要求
- 备注：把这些项目当"偶尔的放松消费"，别当"定期治疗"

12. 结论：四大件的真实排序

- 成本：零
- 说人话：按性价比排：足浴（免费到低成本、安全、助放松）＞自我穴位按压＞刮痧≈拔罐（短期肌肉放松、有皮肤风险）＞艾灸（证据弱、有烫伤风险）。它们共同的位置是"亚健康放松手段"，不是治疗，更不是排毒
- 收益：一张给养生馆消费的清醒剂
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：本节证据综合
- 备注：真要去，先查禁忌、看资质、拒绝预付卡

9. 食疗与药膳，怎么吃真能改善状态

"吃"是养生里水最深的一章：一边是《中国居民膳食指南》的硬证据，一边是阿胶燕窝人参的软营销。这一节的思路：把日常吃对（证据 A）和辨证施膳（证据 C）分开讲，把补品溢价逐个拆掉。

1. 辨证施膳：中医食疗的官方逻辑

- 成本：零
- 说人话：中医食疗的核心是"因人施膳"：按体质和证候选食材的性味（寒热温凉）。气虚用山药大枣、痰湿少肥甘、阴虚食甘凉、阳虚食温补——方向来自辨证，不是来自"这个食物有营养"
- 收益：理解药膳与传统营养学的分野
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：《中医食疗学》因人施膳原则；《亚健康中医临床指南》（2020）饮食调摄建议
- 备注：它提供的是"饮食方向"而非治疗，别指望食材替代药物

2. 底线的归底线：先吃对，再谈辨证

- 成本：零
- 说人话：任何体质调理都建立在吃对的基础上：蔬菜 300–500 克、水果 200–350 克、全谷物杂豆 50–150 克、鱼禽肉蛋 120–200 克、奶 300–500 克、大豆坚果 25–35 克，少糖少酒。这些来自《中国居民膳食指南（2022）》的证据，远强于任何"养生吃法"
- 收益：把养生拉回证据最硬的那一层
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中国营养学会《中国居民膳食指南（2022）》
- 备注：和《饮食》分册衔接：本节只讲"状态"视角的增量

3. 气虚质的餐桌：山药、大枣、小米

- 成本：每月几十元
- 说人话：易疲劳气短的自评气虚者，传统建议健脾益气的平和食材：山药（蒸食最佳）、大枣（每天 3–5 枚，别过量）、小米、莲子、白扁豆。它们确实是优质碳水加膳食纤维，但"补气"本身没有 RCT 证据
- 收益：便宜、安全、味道好的入门食疗
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：气虚质饮食调摄的传统共识；GB/T 46939—2025 解读
- 备注：大枣含糖不低，血糖异常者控制量

4. 阳虚与阴虚：一个求温，一个求凉

- 成本：零到少
- 说人话：阳虚（怕冷）：牛羊肉、生姜、胡椒、桂圆适量，少生冷。阴虚（怕热口干）：鸭肉、银耳、百合、绿豆、梨、冬瓜，少辛辣燥热。两套方向相反——所以"养生食谱"不能通用，这也是辨证施膳唯一靠谱的部分
- 收益：按体质方向吃，而不是跟着网红食谱吃
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：人民日报健康客户端 2026-04 国标解读（熊暑霖）
- 备注：方向的证据是 C，但"吃错方向会不舒服"的体感是真实的

5. 铁和 B12：疲劳人群最该看的两样营养素

- 成本：膳食调整，零到低成本
- 说人话：缺铁和缺 B12 是疲劳最常见的营养原因。红肉、动物肝脏、血制品补铁；B12 几乎只在动物性食物中（肉蛋奶），纯素食者必须补剂或强化食品。维生素 C 促进铁吸收，茶和咖啡抑制——随餐饮茶是常见失误
- 收益：用食物解决一类确定的疲劳
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：《中国居民膳食指南（2022）》；缺铁疲劳的 RCT 证据（BMJ）
- 备注：先查铁蛋白和 B12 再决定，别盲目大补

6. 咖啡因：会用是工具，用错是疲劳源

- 成本：每天几元
- 说人话：咖啡因提升警觉和注意力的证据充分，健康成人每天 400mg（约 3–4 杯美式）以内安全。但两个坑：下午喝影响当晚睡眠结构，把疲劳拖成恶性循环；奶茶的咖啡因加糖组合，提神五分钟、崩溃两小时
- 收益：把提神成本从保健品降到咖啡，且不被反噬
- 证据等级：A
- 风险：中（用错时机）
- 来源：咖啡因安全摄入量与睡眠影响的系统评价
- 备注：孕期限 200mg/天；下午 2 点后尽量不喝

7. 阿胶、燕窝、海参：贵在稀缺，不在功效

- 成本：零（认知成本）
- 说人话：阿胶是驴皮熬制的胶原蛋白——水解后主要是氨基酸，和一块瘦肉的蛋白质没有本质区别，所谓"补血"依赖的是传统功效叙述而非 RCT；燕窝是唾液酸加蛋白质，海参是低质蛋白。三者的性价比都远低于鸡蛋牛奶红肉
- 收益：一年省下几千到几万的"滋补"预算
- 证据等级：B
- 风险：低（主要是钱包风险）
- 来源：食品成分分析；EBSCO 等循证评述对滋补品的评估
- 备注：燕窝的过敏风险和重金属残留反而是真问题

8. 人参：药典收录，但不是"抗疲劳神药"

- 成本：零（认知成本）
- 说人话：《中国药典》收录人参，功效是"大补元气、复脉固脱、补脾益肺、生津养血、安神益智"——但这是医典功效描述，不等于日常保健有效。2023 年一篇 19 项试验的 meta 显示人参降疲劳无显著整体效果；且实证热证者不宜，长期大剂量有血压、失眠风险
- 收益：把"百草之王"请回药品位置
- 证据等级：B
- 风险：中（与抗凝药等有相互作用）
- 来源：2023 年人参降疲劳 meta 分析（19 项试验）；《中国药典（2020 年版）》
- 备注：人参是药材，不是食材，不辨证别乱吃

9. 药膳的坑：药材入膳不等于随便吃

- 成本：零
- 说人话：药膳用错比不用更糟：附子、半夏是处方药级别的毒性药材，出现在"养生汤"里就是违法添加；何首乌入膳有肝损病例；即便是"温和"的药食同源名单（既是食品又是药品的那批），也讲剂量和体质适配
- 收益：避开药膳最危险的一角
- 证据等级：A
- 风险：高（对违规药膳）
- 来源：国家食品安全标准《按照传统既是食品又是中药材的物质目录》；何首乌安全性公告
- 备注：看到"养生汤里放附子"，直接离开

10. 膏方与进补：一个被营销重构的传统

- 成本：零（认知成本）
- 说人话：传统膏方是"一人一方、医师定制、冬令进补"的处方行为，价格是药材加人工。市面上的成品膏是把辨证产品化：统一配方、统一话术、加糖加蜜好入口。前者是医疗，后者是快消品
- 收益：分清"膏方"的医疗版和商业版
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：膏方的传统制备规范与现行商品营销模式的对比
- 备注：成品膏普遍高糖，血糖异常者尤其要小心

11. 进食节律与状态：早餐、低血糖和晚餐

- 成本：零
- 说人话：状态的节律和进食同步：不吃早餐的人上午疲劳和注意力下降更常见（对应"气血不足"的现代版本）；节食过度导致低血糖性疲劳；晚餐过饱过晚影响入睡。三餐定时比"吃什么补品"更能稳定状态
- 收益：零成本的状态稳定器
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：进食节律与认知、疲劳关系的研究
- 备注：和《减重》分册的节律建议一致

12. 结论：会吃比会补重要一百倍

- 成本：零
- 说人话：这一节的排序很清楚：吃对三餐（A 级证据）＞补缺乏的营养素（A 级，先查再补）＞按体质方向吃（C 级，安全便宜）＞买滋补品（B/C 级且贵）。把钱花在红肉鸡蛋蔬菜上，比花在阿胶燕窝上，证据和性价比都高一个数量级
- 收益：一张食疗性价比总表
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：本节证据综合
- 备注：所有"超级食物"都是营销词，没有单一食物能拯救状态

10. 保健品与补剂，抗疲劳证据分级表

保健品是养生消费的最大单类。这一节给一份抗疲劳补剂的证据分级表：哪些"补缺乏才有效"、哪些"证据弱"、哪些"有反效果"。结论先行——没有任何补充剂被证明能提升健康人的整体能量。

1. 总原则：补缺乏，不补"想像"

- 成本：零
- 说人话：补剂的全部合理场景是"纠正缺乏"：缺铁补铁、缺 B12 补 B12。对营养素本已充足的人，额外补充没有能量收益——这是 EBSCO 循证评述的原话：没有任何草药或补充剂被证明能提升健康人的整体能量和幸福感
- 收益：一条原则省下整柜保健品
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：EBSCO Complementary & Alternative Medicine 评述
- 备注：先花几百元抽血，再决定买不买——顺序不能反

2. 铁：先查铁蛋白，再谈补

- 成本：一次铁蛋白检查
- 说人话：BMJ 一项 144 名疲劳女性的 RCT：疲劳下降 29%（安慰剂 13%），且集中在铁储备低的人群——注意她们还没到"贫血"诊断标准。反过来，不缺铁的人补铁没有收益，过量伤肝
- 收益：疲劳人群证据最硬的一个补剂
- 证据等级：A
- 风险：中（无诊断补铁有害）
- 来源：BMJ 铁剂治疗疲劳女性 RCT（144 例）
- 备注：铁蛋白低于 30 μg/L 通常提示储备不足（各实验室参考值略不同）

3. 维生素 B12：这几类人确实该补

- 成本：每月几元
- 说人话：B12 几乎只存在于动物性食物。纯素食者、60 岁以上（吸收下降）、长期服二甲双胍或抑酸药的人、胃肠手术后人群，是缺乏高风险群。缺乏时疲劳、舌炎、手脚麻木都可能出现——补上就有效
- 收益：精准锁定一个高性价比补剂场景
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：B12 缺乏风险因素与补充证据；《中国居民膳食营养素参考摄入量（2023 版）》
- 备注：B12 水平正常的人补了不会更精神

4. 镁：与压力和肌肉相关的微量元素

- 成本：每月几十元
- 说人话：镁参与三百多种酶反应，欧盟 EFSA 批准"镁有助减少疲劳"的功能声称。但证据主要来自缺乏或肌肉问题人群（如痉挛）。深绿叶菜、坚果、全谷物吃够的人通常不缺
- 收益：一类有边缘证据的补充
- 证据等级：B
- 风险：低（肾功能不全者补镁要医生指导）
- 来源：镁与疲劳的功能声称及临床研究综述
- 备注：大剂量镁泻肚是常见"副作用"，也是吸收上限

5. 辅酶 Q10：他汀使用者的对症选项

- 成本：每月几十到上百元
- 说人话：2022 年一篇 13 项试验的 meta 显示辅酶 Q10 可降低疲劳感，证据最强的人群是心脏病患者和他汀相关肌痛者。健康年轻人吃着"抗疲劳"，证据不足
- 收益：给一个被过度营销的补剂找到真实位置
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：辅酶 Q10 2022 meta（13 项试验，1126 人）
- 备注：他汀引起肌肉痛应先找医生，而不是自己加补剂

6. 叶酸与维生素 D：混合证据

- 成本：每月几元
- 说人话：叶酸与 B12 协同，主要和缺乏相关。维生素 D 更微妙：低水平与疲劳相关，但补充后的 RCT 结果不一致——欧洲 2022 年的大型 meta 显示常规补充维 D 并不改善健康成人的疲劳和情绪
- 收益：避开两个"习惯性被买"的补剂
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：维生素 D 大型 meta 分析（2022）；叶酸缺乏研究
- 备注：日照少的老年人查维 D 有意义，跟风补没必要

7. 人参：19 项试验的 meta 说不显著

- 成本：零（认知成本）
- 说人话：2023 年一篇汇总 19 项试验的 meta 分析：人参未能显著降低疲劳。加上价格高、有血压和睡眠副作用、与抗凝药相互作用——性价比在补剂表里排倒数
- 收益：把"百草之王"打回原形
- 证据等级：B
- 风险：中
- 来源：2023 年人参降疲劳 meta 分析（19 项试验）
- 备注：人参在《中国药典》里是药材，用它抗疲劳本身就是错位使用

8. 红景天、玛咖、虫草、刺五加：弱证据俱乐部

- 成本：零（认知成本）
- 说人话：所谓"适应原"（adaptogens）全家桶——红景天只有几项小试验、结果矛盾；玛咖的人体证据零散；冬虫夏草的人体证据几乎没有，且砷超标风险被监管通报过。它们的共同点是：传统用法悠久，现代证据薄弱
- 收益：认清"高原神草"营销与证据的距离
- 证据等级：C
- 风险：中（虫草重金属）
- 来源：EBSCO 抗疲劳草药评述；虫草砷超标监管通报
- 备注：虫夏草不是冬虫夏草——后者才是被炒的那个

9. L-茶氨酸加咖啡因：唯一"有效"的功能组合

- 成本：每月几十元
- 说人话：L-茶氨酸（茶中的氨基酸）加咖啡因的组合，对注意力和专注有小而一致的改善——2026 年一篇综述认为茶氨酸对注意力有小改善，与咖啡因同用时更明显。对应到生活就是：好好喝杯茶或咖啡，比买"专注力补剂"便宜
- 收益：认清功能组合的证据位置
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：L-茶氨酸与注意力的 2026 综述
- 备注：单买茶氨酸补剂的意义不大，茶里本来就有

10. 肌酸：运动表现的证据，不是"抗疲劳"

- 成本：每月几十元
- 说人话：肌酸提高高强度运动表现和力量训练适应的证据充分（A 级），对"提神抗疲劳"则基本无关。它的适用场景是健身人群，而且需要配合训练——不训练的人吃它只是给肾脏加负担
- 收益：把一个健身补剂从"抗疲劳"货架撤下来
- 证据等级：A
- 风险：低（肾功能不全者避免）
- 来源：肌酸与运动表现的立场声明（国际运动营养学会）
- 备注：与《减重》分册衔接：保肌场景才考虑

11. 大剂量抗氧化剂：这一类可能越补越糟

- 成本：零（认知成本）
- 说人话：针对吸烟者的 β-胡萝卜素试验发现，大剂量抗氧化补充剂反而增加死亡风险；大剂量维生素 E 的试验也未见收益。自由基致衰的理论没错，但"补剂清除自由基"是另一回事——抗氧化系统靠的是膳食蔬果的整体模式，不是药片
- 收益：避开补剂里唯一有反证据的一类
- 证据等级：A
- 风险：高（对长期大剂量使用者）
- 来源：抗氧化剂补充剂的大型临床试验（如 CARET、ATC 试验）
- 备注：吃够蔬果，别吃药片

12. 选购与监管：认准蓝帽子，读警示语

- 成本：零
- 说人话：中国保健食品的合法标识是"蓝帽子"加注册号/备案号；2019 年起市场监管总局要求标签上必须印"保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病"。没有蓝帽子的"功能性食品"宣传功效即违规；海淘保健品成分不明、剂量凭标
- 收益：把住入口前的最后一道关
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：市场监管总局《保健食品标注警示用语指南》（2019）；《食品安全法》
- 备注：抽血发现确实缺什么再针对性补，永远是最优解

11. 起居作息与环境，状态管理的日常基建

调理养生到最后，落点都是日常：几点睡、几点见光、坐多久、喝不喝酒。这一节讲的都是免费或近乎免费的动作——它们是状态的地基，做不好，上面任何调理都是沙上建塔。

1. 起居有常：固定作息是第一养生

- 成本：零
- 说人话：《黄帝内经》把"起居有常"放在养生第一位，现代证据完全站在它这边：固定的入睡和起床时间比总时长更能稳定睡眠质量和日间状态。周末补觉和作息漂移是状态波动的常见来源
- 收益：最古老的建议，至今证据最硬
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：睡眠规律性与健康结局的研究；《睡眠》分册循证结论
- 备注：先固定起床时间，入睡时间会自己跟上来

2. 晨间光照：免费的"开机"仪式

- 成本：零
- 说人话：起床后 30 分钟内到户外接受自然光 10–20 分钟，是重置生物钟最有效的手段：褪黑素按时退场、皮质醇正常升峰、晚上到点才困。阴天也有效（室外照度仍是室内几倍）
- 收益：零成本的节律修复工具
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：昼夜节律与光照的研究（时相反应曲线）
- 备注：通勤路上见光也算，墨镜会打折

3. 久坐打断：每 60 分钟起身 3 分钟

- 成本：零
- 说人话：久坐独立于运动量损害代谢和状态：连续静坐 60 分钟以上，下肢血流和代谢活性显著下降。每 60 分钟起身 3–5 分钟（接水、上厕所、拉伸）就能打断这个效应，比下班后突击健身更贴近身体的实际节律
- 收益：一个工位可执行的动作
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：久坐行为打断的研究；WHO 身体活动建议
- 备注：设个每小时响一次的闹钟，比意志力可靠

4. 20-20-20 护眼：屏幕时代的必要动作

- 成本：零
- 说人话：每 20 分钟看 20 英尺（6 米）外 20 秒。视疲劳本身也是"状态差"的组成部分：眼干、头痛、注意力下降。配合有意识的多眨眼（屏幕前眨眼频率减半），干眼症状能明显缓解
- 收益：缓解一类被忽视的疲劳源
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：视疲劳与干眼的临床建议（眼科学会科普口径）
- 备注：人工泪液比"抗疲劳眼药水"安全（后者多含血管收缩剂）

5. 睡前一小时：屏幕、蓝光和"再刷一条"

- 成本：零
- 说人话：屏幕伤睡眠的不只是蓝光，更是内容唤醒——工作消息、短视频、游戏让大脑持续兴奋。睡前一小时切换到低刺激活动（纸质书、拉伸、白噪音），入睡潜伏期缩短的证据比"蓝光眼镜"更一致
- 收益：把失眠的最大可控因素按住
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：睡眠卫生教育；睡前使用电子设备与睡眠的研究
- 备注：手机放客厅充电，比任何自律技巧都有效

6. 午睡：20 分钟的精确剂量

- 成本：每天 20 分钟
- 说人话：午睡 10–30 分钟（不进深睡）能恢复警觉和认知，超过 30–60 分钟容易睡深，醒来昏沉（睡眠惯性），且影响当晚睡眠。下午 3 点后尽量不睡
- 收益：一个可量化的恢复工具
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：小睡时长与睡眠惯性的研究
- 备注：睡不着也闭目养神 20 分钟，收益类似

7. 酒精：唯一"常用"的状态破坏者

- 成本：零
- 说人话：睡前酒是经典陷阱：它让人更快入睡，但显著破坏后半夜的睡眠结构（深睡和 REM 减少），结果是"睡着了但没恢复"，晨起口干头痛。任何剂量酒精都不改善睡眠，只改善入睡错觉
- 收益：把最常见的一种"自我调理"请出场
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：酒精对睡眠结构影响的研究（睡眠医学共识）
- 备注：借酒减压的人，用第 6 节的呼吸训练替代

8. 吸烟与尼古丁：提神是假象

- 成本：零
- 说人话：尼古丁的半衰期约 2 小时，"提神"其实是缓解戒断反应——不吸烟时的疲劳本身就是尼古丁造成的。戒烟 2–4 周后，多数人的基础精力水平会回升
- 收益：认清一个化学依赖循环
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：尼古丁戒断与症状周期的研究
- 备注：戒烟任何年龄开始都有收益

9. 环境三件套：温度、通风、噪音

- 成本：近乎零
- 说人话：卧室 18–22℃、睡前一小时通风；白噪音或耳塞应对噪音敏感；加湿器在干燥季节把湿度放到 40%–60%（缓解晨起口干和咽痛）。这些是便宜但确定的环境优化
- 收益：把睡眠环境调到不出错
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：睡眠环境建议；室内湿度与健康的研究
- 备注：加湿器不用纯净水会喷出菌团，反而致病

10. 换季与季节性情绪：秋冬的"累"有出处

- 成本：零
- 说人话：日照缩短会打乱一部分人的节律和情绪：秋冬犯困、嗜睡、情绪低、想吃碳水——季节性模式的证据充分。对策就是第 2 条的光照管理（尤其上午）加规律运动，严重到影响功能的要求诊（季节性情感障碍有标准治疗）
- 收益：给"入秋就累"一个科学解释
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：季节性情感障碍（SAD）研究；光照疗法证据
- 备注：标准光照疗法是 10000 lux、每天 20–30 分钟

11. 信息过载与数字极简

- 成本：零
- 说人话：睡前刷手机、通勤刷短视频、工作时被消息切碎——持续的碎片输入本身就是认知疲劳源。低成本实验：每天设两个"无屏幕时段"（如起床后 1 小时、睡前一小时），坚持两周对比疲劳日记
- 收益：给大脑一个不被切碎的机会
- 证据等级：B
- 风险：低
- 来源：注意恢复理论与数字疲劳研究
- 备注：不是戒网，是设边界

12. 结论：基建免费，先做免费的

- 成本：零
- 说人话：这一节所有动作的成本都是零或接近零：固定作息、晨间见光、每小时起身、20-20-20、睡前一小时离屏、20 分钟午睡、限酒、戒烟。它们构成状态的"地板"——地板不打牢，功法、补剂、推拿都只是往漏水的桶里加水
- 收益：全书的执行顺序一句话
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：本节证据综合
- 备注：先做两周，再看要不要花钱

12. 避坑清单，养生智商税大全

这一节是全书的反面清单：把养生行业最常用的套路逐个拆掉。判断标准很简单——宣称治百病、用科学名词包装、说不清机制、有免费体验噱头的，基本都是坑。

1. 智商税的六个共同特征

- 成本：零
- 说人话：①宣称"医院治不好的我能治"；②用"酸性体质""自由基""量子""远红外"等科学名词堆砌但说不出机制；③有"体验店""免费试用""领鸡蛋"噱头；④一种产品治多种不相干的病；⑤强调"纯天然、无副作用"；⑥把暂停就复发的效果说成"根治"
- 收益：一张通用识别器
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：官方科普辟谣口径（新疆疾控等）；中消协消费警示
- 备注：六条中任意两条，转身走

2. 酸碱体质：伪概念，创始人被罚 1.05 亿美元

- 成本：零
- 说人话："酸性体质是百病之源"是彻头彻尾的伪科学：人体血液 pH 恒定在 7.35–7.45，由肺、肾和缓冲系统精密控制，饮食根本改变不了它。这个理论的创始人 2018 年在美国被罚 1.05 亿美元并当庭承认骗局
- 收益：拆掉养生第一大树
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：央视网、科技日报对"酸碱体质"骗局的报道（2018）
- 备注：衍生品：碱性水、碱性食品、pH 试纸测体质——全是同一门生意

3. 排毒足贴：变黑是铁粉氧化

- 成本：零
- 说人话：足贴"一夜吸出毒素"的真相：贴里含铁粉、竹醋粉，遇到脚汗湿气就氧化变黑——不贴脚、贴在任何潮湿处也一样黑。人体排毒靠肝肾，足底没有排毒生理功能
- 收益：拆掉足疗养生馆的镇店之宝
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：官方科普辟谣（成分与机制说明）
- 备注：同款逻辑还有"湿气贴""艾灸出油是毒"

4. 清肠茶与"排肠毒"：泻药加结肠黑变

- 成本：零
- 说人话：″宿便十几斤″是伪概念——食物残渣在肠道停留 1–3 天完全正常。而多数清肠茶、排毒产品靠添加番泻叶、大黄等刺激性泻药起效，长期使用导致结肠黑变病（肠子真的变黑）和肠道功能退化，越喝越便秘
- 收益：避开一类真能把人喝坏的″养生″
- 证据等级：A
- 风险：高（对长期使用者）
- 来源：央视网关于通便产品与结肠黑变的报道；食品安全监管信息
- 备注：同样要警惕的还有″排毒胶囊″″果蔬泻盐″

5. 功能水家族：富氢水、小分子水、低氘水

- 成本：零（认知成本）
- 说人话：富氢水：氢气在水中溶解度极低，几分钟内经肺排出，″选择性抗氧化″停留在细胞和动物实验，没有任何人体临床证据。小分子团水：水分子团簇是瞬时动态结构，不存在稳定的″大/小分子团″商品。低氘水：没有健康功效证据
- 收益：省下一笔长期买水钱
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：官方科普辟谣口径（氢医学研究阶段的客观描述）
- 备注：喝水就喝白开水或矿泉水，贵的只是包装

6. 酵素、抗糖丸、大剂量抗氧化剂

- 成本：零（认知成本）
- 说人话：口服酵素：酶是蛋白质，到胃里被变性、到小肠被拆成氨基酸，″神奇酵素″和一块瘦肉没有区别；自制酵素还容易霉菌和亚硝酸盐超标。抗糖丸：没有高质量证据能抑制人体皮肤糖化。大剂量抗氧化剂：β-胡萝卜素试验显示反增某些风险
- 收益：拆掉″吃进去调理″的三件套
- 证据等级：A
- 风险：中（对大剂量使用者）
- 来源：EBSCO 等循证评述；抗氧化剂大型临床试验
- 备注：水果直接吃，就是最好的″酵素″

7. 磁疗、高电位、量子保健品

- 成本：零（认知成本）
- 说人话：磁疗床垫手环：静态磁场强度不足以穿透人体产生生物学效应（医院里的经颅磁刺激是强几个数量级的设备，两回事）。高电位治疗仪："几千伏静电场激活细胞"是营销话术。量子产品：中国消费者协会 2021 年明确——所有打着"量子"旗号的日常生活用品均为虚假宣传
- 收益：把最贵的几类智商税清零
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中消协 2021 年消费警示；官方科普辟谣
- 备注：玉石床、频谱能量屋、托玛琳汗蒸房是同一家族

8. 辟谷与极端断食：普通人别碰

- 成本：零
- 说人话："辟谷排毒、重启免疫"没有任何人体证据。健康人群短期轻断食或许无害，但长时间严格断食导致营养不良、低血糖、电解质紊乱；糖尿病患者、孕妇、青少年、进食障碍史人群有明确危险
- 收益：避开一类被包装成"修行"的风险行为
- 证据等级：A
- 风险：高（对高风险人群）
- 来源：北京协和医院等专家的公开科普；断食研究现状（动物实验为主）
- 备注：想尝试轻断食，先看《减重》分册的 5+2 方案

9. 以形补形与食物相克

- 成本：零
- 说人话：吃核桃补脑、吃腰子补肾、以形补形全部没有证据支持；"食物相克"的经典组合（柿子螃蟹、维生素 C 加虾）也全部被实验推翻。真正要注意的搭配只有几个：酒精加头孢（双硫仑）、西柚加他汀等药物
- 收益：把饭桌上的焦虑清空
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：食物相克的系统性证伪实验（央视等）；食物-药物相互作用的药学资料
- 备注：唯一要记住的"相克"是酒和药

10. 节气养生与进补营销

- 成本：零
- 说人话："秋冬进补、节气养生"作为文化传统没问题，作为商业话术就是问题：把"此时进补"和消费者焦虑绑定，再卖你一套并不对证的膏方、礼盒。体质偏颇且经医师辨证后进补才有意义；跟节气消费式进补，花的是冤枉钱
- 收益：分清文化传统和营销周期
- 证据等级：C
- 风险：低
- 来源：膏方与进补的传统规范对商品营销的对照（见第 9 节）
- 备注：中秋、冬至、三伏——日历上全是他们的 KPI

11. 养生馆的体验式推销：从免费到办卡的三步

- 成本：零
- 说人话：标准剧本：免费体验（鸡蛋、理疗、旅游）→ 恐吓话术（湿气重、经络堵、毒素堆积）→ 大额办卡。对策：免费的最贵；不进体验店；不办预付卡；不买"只有这里能修"的仪器
- 收益：把老年人的养老钱守住，也守住自己的
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：中消协及各地消协的预付卡投诉警示
- 备注：这一套的目标客户从来不是读过这本书的人

12. 最后的忠告：免费的都做好了，再谈花钱

- 成本：零
- 说人话：全书最后一条：证据最充分的养生方式，没有一样是花钱的——睡好、动够、吃对、限酒、戒烟、晒太阳。如果这些你还没做到，任何补剂、推拿、仪器都是在给漏水的桶加水。先做免费的两周，再决定要不要为"感觉好一点"付钱
- 收益：全书的一句话总结
- 证据等级：A
- 风险：低
- 来源：本系列性价比框架；与官方科普口径一致
- 备注：健康出了问题，先看医生——这本书的全部内容都以此为前提